Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Pelotas

Av. Ferreira Viana, 1134 - Bairro: Areal - CEP: 96085000 - Fone: (53)3026-8500 - Email: frpelotas5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5037160-77.2022.8.21.0022/RS

AUTOR: HELOISA HELENA FIGUEIREDO ARANHA
RÉU: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SENTENÇA

HELOÍSA HELENA FIGUEIREDO ARANHA ajuizou a presente ação em face de **UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL**. Disse 1) que é credenciada ao plano de saúde **UNIMED**, e que tem indicação para uso oral da medicação ABEMACICLIBE (VERNEZIOS) 150 mg, para tratamento da moléstia CID C50.9 NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA, estágio clínico III (doença localmente avançada); 2) que após ser submetida a tratamento cirúrgico, bem como *tratamento adjuvante com poliquimioterapia,* foi prescrito o uso domiciliar da medicação, com início imediato; 3) que o tratamento foi negado pele ré, ao argumento de que não se enquadra nos critérios para a autorização do medicamento conforme estabelecido pela ANS, embora a medicação esteja cadastrada na ANS; 4) que a medicação *tem potencial de retardar o surgimento da resistência ao tratamento hormonal, prolongando significativamente o tempo de controle da doença, sendo superior a quimioterapia em resultados e com melhor perfil de toxicidade quando comparado a quimioterapia convencional;* 5) que tal medicação terá impacto positivo em sua qualidade e tempo de vida, quando comparada a terapia hormonal isolada ou mesmo a quimioterapia. Em sede de tutela de urgência, pediu fosse o réu instado a fornecer o tratamento de forma imediata. Ao final, que o réu fosse condenado ao fornecimento da medicação ABEMACICLIBE (VERNEZIOS) 150 mg, 2 comprimidos via oral ao dia, uso contínuo e por tempo indeterminado. Pediu a gratuidade judiciária. Juntou documentos.

Deferido o beneficio da gratuidade judiciária e instada a parte autora à emendar a inicial, retificando-se, ainda, o valor atribuído à causa.

Sobreveio emenda à inicial, oportunidade em que elucidada a necessidade de utilização de 1 comprimido, via oral, a cada doze horas, por tempo indeterminado.

Deferida a antecipação de tutela.

Interposto agravo de instrumento pela parte demandada.

Citada, a parte ré apresentou contestação. Preliminarmente, arguiu a necessidade de consulta ao NAT-JUS. No mérito, disse 1) que o contrato da parte autora foi celebrado após o advento da Lei n. 9.656/98, e se submete às resoluções da ANS; 2) que inexiste prova técnica apresentada pela parte autora a evidenciar a indicação de uso do medicamento postulado para a doença que lhe acomete; 3) que o tratamento não faz parte do rol da ANS e não possui cobertura; 4) que as operadoras de planos de saúde somente estão obrigadas a atender os procedimentos previstos no rol atribuído pelo órgão oficial; 4) que o texto da Lei 14.454/2022 é demasiadamente amplo, aguardando regulamentação pela ANS. Teceu considerações normativas incidentes à espécie, manifestando-se, ainda, acerca da execução de valores nos mesmos autos na hipótese de julgamento final de improcedência. Ao cabo, pediu o julgamento de improcedência da pretensão autoral. Juntou documentos.

Sobreveio réplica.

Em decisão saneadora, rechaçada a preliminar, invertido o ônus da prova e instadas as partes acerca do interesse na dilação probatória.

A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a parte requerida postulou a *consulta ao NAT-JUS.*

Indeferido o pedido da parte demandada.

Determinado o aguardo pelo julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte ré.

Noticiado o julgamento do agravo, o qual foi desprovido.

Postulou a parte autora a procedência da pretensão.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Relatado, DECIDO.

A lide gira em torno de dever da ré de fornecer o medicamento ABEMACICLIBE (VERNEZIOS) 150 mg, prescrito para tratamento oncológico (CID 10 C50.9).

Como já mencionado quando do exame do pedido liminar, segundo previsto pelo art. 12, inc. I, alínea ‘c’, e inc. II, alínea ‘g’, da Lei n. 9.656/98, as operadoras de plano de saúde têm obrigação de garantir aos beneficiários (das modalidades atendimento ambulatorial e internação hospital) cobertura para tratamento de neoplasia, incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos prescritos pelo médico assistente, ainda que de uso oral e em âmbito domiciliar:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)

Para além disso, conforme evidencia a documentação anexada pela parte autora, sobretudo aquela de evento 1, OUT15, a medicação postulada **possui registro na ANVISA, o que fora igualmente observado na ementa anexada quando da decisão liminar, que ora ratifico:**

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora, em sede de tutela de urgência, requer "o medicamento ABEMACICLIBE 150mg, e tomar 1 CP, VO, de 12/12 por tempo indeterminado".

Para tanto, relatou ser acometida por neoplasia mamária maligna, em estágio 3, tendo sido-lhe prescrito o medicamento "Verzenios (Abemaciclibe)" para a estabilização de seu quadro, não sendo recomendados em seu caso os tratamentos convencionais, a exemplo da quimioterapia, por não possuírem a mesma eficácia. Ademais, narrou ter solicitado o fármaco junto à requerida, o que lhe foi negado, sob a justificativa de que este não consta no rol da ANS.

Pois bem.

Consoante dispõe o art. 300 do CPC, são requisitos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a parte autora comprova a prescrição do tratamento requerido, o qual foi expressamente indicado pelo médico que a acompanha, conforme laudo juntado em evento 1, DOC8, bem como a negativa de custeio do medicamento pela requerida (evento 1, DOC10), pelo que verifico a presença do requisito da probabilidade do direito.

Do mesmo modo, presente o requisito do perigo de dano, porquanto demonstrada de forma expressa, no referido laudo, a imprescindibilidade do fármaco requerido, o qual inclusive dispõe "que a indicação citada tem relevância significativa como melhor alternativa de tratamento quando comparada a terapia hormonal isolada, principalmente em paciente com grande volume de doença, o que traz maior risco".

Nesse sentido:

*APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ABEMACICLIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE COBERTURA RECONHECIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravante que, forneça enquanto houver comprovada indicação médica, o fármaco ABEMACICLIBE 150mg (Verzenio), sendo que, no prazo de 5 dias, deve realizar a entrega da quantidade suficiente para o período de 2 meses de tratamento (120 comprimidos), sob pena de multa de R$25.000,00(...) por ato atentatório à dignidade da Justiça, na forma do art. 77, inciso IV, §§1º a 5º do CPC.Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. Destaca-se que as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998.**Considerando tratar-se de medicação antineoplásica, necessária para o tratamento da parte autora, e ainda considerando que o fármaco possui registro na ANVISA, bem como se mostra imprescindível para a boa terapêutica da autora, conforme expressamente elencado no laudo médico, porquanto a exclusão de cobertura se mostra abusiva, pelo que a seguradora deve fornecer a medicação requerida nos precisos termos do laudo prescrito pelo médico responsável pelo tratamento da beneficiária.**Consoante recentes julgados do egrégio STJ, restou consolidado que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).Assim, conclui-se que devem ser cobertos, pelos planos de saúde, a medicação antineoplásica indicada para o tratamento de saúde da parte autora, eis que além de ser medicação antineoplásica, consta atualmente, do rol de cobertura obrigatória da ANS - Resolução nº 465/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento, Nº 51055878120218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 31-03-2022)*

Isso posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que FORNEÇA à parte autora o medicamento ABEMACICLIBE 150 mg (VERZENIOS), até a decisão final do feito, sob pena de aplicação de multa diária.

Calha ainda registrar a alteração normativa promovida pela Lei n. 14.454/22, que alterou a Lei n. 9.656/98, a qual, nos §§ 12 e 13 do art. 10, passou a determinar:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Ora, inegavelmente a medicação é de ser considerada eficaz, sobretudo pois prescrita pelo médico assistente (evento 1, RECEIT9), acompanhada, ainda, de fundamentado laudo a evidenciar sua adequação ao caso concreto (evento 1, LAUDO8).

Outrossim, no curso do processo não foram produzidas provas outras que modificassem o entendimento do juízo já externado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Ainda, comprovada a realização de pedido administrativo, negado nos seguintes termos:

Procedimento - Medicamento: VERZENIOS 100 MG COM REV CT BL AL AL X 60

Motivo: PARECER MÉDICO: A autorização da TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER, nos termos da Resolução Normativa - RN nº 465 (art. 3º, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está condicionada ao atendimento da Diretriz de Utilização (DUT) nº 64, o que no caso não ocorre, pois, o medicamento VERZENIOS (abemaciclibe), solicitado para o tratamento ADJUVANTE de câncer de mama, classificação T4, N2, Mx, consta na lista dos medicamentos cobertos pela referida Diretriz de Utilização, porém, para o tratamento de câncer de mama AVANÇADO OU METASTÁTICO, com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo) : em combinação com um inibidor da aromatase como TERAPIA ENDÓCRINA INICIAL; em combinação com FULVESTRANTO como terapia endócrina inicial ou após terapia endócrina; ou como AGENTE ÚNICO, após progressão da doença após o uso de terapia endócrina e 1 ou 2 regimes quimioterápicos anteriores para DOENÇA METASTÁTICA.

Cumpre referir que a ausência de previsão de determinado tratamento no rol da ANS ou ausência de enquadramento às diretrizes de utilização, por si só, não são suficientes para afastar o dever de cobertura. Referido rol não é taxativo, mas, ao contrário, elenca os procedimentos mínimos que devem ser postos à disposição dos segurados.

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

No caso, o laudo médico juntado atesta a necessidade do medicamento em questão para tratamento da moléstia apresentada pelo autor, o que, ademais, também fora reconhecido pelo TJRS por ocasião do agravo de instrumento apreciado, quando assim decidiu:

No caso dos autos, a toda evidência se está diante de uma tutela provisória de urgência, razão de se exigir para sua concessão os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, da presença da probabilidade do direito e da demonstração ou do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo, cumulativamente.

In casu, se verifica que a parte autora, ora agravada, demonstrou a urgência e a verossimilhança necessárias ao deferimento da tutela de urgência, diante da juntada do laudo médico no evento 1 - doc 8, que abaixo reproduzo:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins de justificativa de tratamento oncológico que a Sra. ***Heloisa Helena Figueiredo Aranha,*** 65 anos, é paciente portadora sintomática para a patologia classificada sob o CID C50.9 (neoplasia maligna de mama), estágio clínico III por doença localmente avançada.

A paciente foi diagnosticada com neoplasia de mama, com comprometimento cutâneo e axilar significativo, sendo submetida a tratamento cirúrgico com mastectomia radical modificada a direita em 18 de março de 2022, com resultado de *carcinoma ductal invasor, grau 2, multifocal, implantes neoplásicos em tecido adiposo, invasão de derme, êmbolos neoplásicos linfáticos em derme, e acometimento de 06 linfonodos axilares,* considerada doença estágio clínico IIIB (pT4bN2aM0), com alto risco para recidiva.

Realizou tratamento adjuvante com poliquimioterapia (esquema *Adriamicina/ciclofosfamida* por 4 ciclos seguido de 12 semanas de Paclitaxel) de 10 de maio a 18 de outubro de 2022, com excelente tolerância.

Tem indicação, ainda, de tratamento hormonal adjuvante por apresentar doença receptor hormonal positivo e HER2 negativo. Apresenta indicação de tratamento hormonal com inibidor de aromatase *(Letrozol)* associado a *Abemaciclibe* como melhor alternativa terapêutica.

O tratamento combina a terapia hormonal (inibidor da aromatase) e inibidor seletivo das cinases dependentes de ciclina CDK4 e CDK6, que tem potencial de reduzir o surgimento da resistência ao tratamento hormonal.

O tratamento combinado por 2 anos é superior ao tratamento com hormonioterapia isoladamente, conforme descrito em estudo anexo, demonstrando reduzir em 30% o risco de recidiva de doença dentro do período de acompanhamento, com bom perfil de tolerância e segurança.

Considero, então, que a indicação citada tem relevância significativa como melhor alternativa de tratamento quando comparada a terapia hormonal isolada, principalmente em paciente com grande volume de doença, o que traz maior risco.

O tratamento recomendado já encontra sua indicação em bula, e foi autorizado nessa indicação pela ANVISA (conforme anexo).

Gustavo P. Zerwes
Oncologia Clínica
CREMERS 26607 CPF 804238840-34

Gustavo Pereira Zerwes
CREMERS 26607 / CPF 804238840-34

Percebe-se, a toda evidência, que se trata de medicamento antineoplásico e, diante da urgência do atendimento, inclusive com risco à vida, vai mantida a determinação de cobertura.

No que respeita aos medicamentos, importante ressaltar que as operadoras de plano de saúde deverão respeitar aqueles considerados de adoção e disponibilização obrigatória pelo rol da ANS, inclusive os ***antineoplásicos****, muitos já incluídos no rol de cobertura obrigatória em vigência desde abril de 2021, conforme especificação do Parecer Técnico nº 27/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018*[5].

Por conseguinte, importa ressaltar que a recente Lei nº 14.307 de 03 de março de 2022 altera a Lei nº 9.656/98 dispondo sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar. Neste termos, a nova lei acabou alterando o art. 10 da referida Lei para acrescentar o §6º, que transcrevo:

"Art. 10.

(...)

§ 6º As coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, ***desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades****, observado o disposto no § 7º deste artigo.*

(...)"

E o art. 12 da Lei nº 9.656/98:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar: (...)

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Esse Órgão Fracionário já se manifestou sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA HEMATOLÓGICA MALIGNA, SÍNDROME MIELODISPLÁSICA DE CID 10 - D46.9. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RN 465/2021. DANO MORAL. Trata-se de ação de obrigação de fazer combinada com indenizatória, através da qual a parte autora postula cobertura do tratamento com o medicamento denominado ELTROMBOPAG (REVOLADE), na dose de 150 mg, bem como indenização por danos morias em razão da negativa da cobertura, julgada parcialmente procedente na origem. Negativa de cobertura - Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa. Em procedimento de overruling, no julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, restou consolidado que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos e/ou medicamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde.É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. No caso dos autos, nos termos do laudo médico acostado no evento 1 - laudo 6, o autor apresentava trobocitopenia grave, com sangramentos periódicos e potencialmente letais, sendo o medicamento fundamental para preservação da vida do segurado, de modo que a negativa de cobertura pela requerida se mostra abusiva. Indenização por danos morais - A injusta recusa de cobertura de seguro saúde dá direito ao segurado ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais sofrido. precedentes do e. STJ.Quantum indenizatório - A indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, pois não se pode esquecer que o "quantum" reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, fixo em R$ 5.000,00 (...) o valor da indenização. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA, PROVIDA (Apelação Cível, Nº 51189528720208210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 10-12-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PARA O TRATAMENTO DE NEOPLASIA / CÂNCER. - Em overruling passa-se a adotar o entendimento do STJ de que a ANS realiza verdadeira regulamentação infralegal, a qual decorre de expressa delegação legal de competência e constitui relevante garantia do contratante para assegurar direito à saúde, pois evita a padronização de todos os planos de saúde, impedindo restrição à livre concorrência e, ainda, prima pela autonomia e preservação do equilíbrio contratual e atuarial perante as operadoras. - Assim, as decisões judiciais devem observar o fornecimento de medicamentos obrigatórios, os destinados aos tratamentos de doenças expressamente contratadas e desde que sejam autorizados pela ANVISA, para o tratamento a ser realizado. Entretanto, desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos antineoplásico para o tratamento de câncer / neoplasia (Regorafenibe). - Dano moral: No que se refere à pretensão de condenação da operadora de saúde ao pagamento dos danos morais, recordo que, via de regra, o mero descumprimento contratual não gera danos morais, pois, para a configuração desse dano extrapatrimonial necessária a comprovação de circunstância excepcional. Essa situação excepcional se verifica dos autos, pois o contratante viu-se em situação de extraordinária angústia e humilhação. Danos morais verificados. - No que se refere ao quantum indenizatório, deve ser fixado em valor que repare os transtornos experimentados pela parte no caso concreto, sem implicar enriquecimento ilícito e com a suficiente carga pedagógica. A quantificação deve levar em conta o caráter repressivo e educativo, o tempo de duração da ilicitude, a situação econômico/financeira do ofensor e do ofendido, bem como a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido. Quantum arbitrado em consonância com os precedentes deste Órgão Fracionário. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50475016520218210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-09-2022)

Desta forma, vai mantida a decisão recorrida.

Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de determinar à parte demandada o fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE (VERNEZIOS) 150 mg, em quantidade e periodicidade de acordo com a prescrição do médico assistente (evento 1, RECEIT9), sob pena de bloqueio de valores.

Condeno a ré ao pagamento das custas do processo e honorários de advogado, arbitrados em 15% do valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação pelo IGP-M e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Depois do trânsito em julgado, dê-se baixa, observando o procedimento de praxe quanto a eventuais custas pendentes (lembrando que o cumprimento de sentença deverá ser distribuído com novo número e vinculado ao presente).

Documento assinado eletronicamente por **FELIPE MARQUES DIAS FAGUNDES, Juiz de Direito**, em 13/9/2023, às 15:49:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10045936985v10** e o código CRC **7a92642a**.

---

5. http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_PARECER_27-2018_MEDICAMENTOS%20ANTINEOPLSICOS%20ORAIS_VERSO%20FINAL_27122017.pdf ↩